

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALA DE SOLEDAD DE DE JONG GIERVELD (DJGLS-11 / DJGLS-6)

Eje II: Procesos Psicológicos • Evaluación Dimensional de la Soledad Emocional y Social

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escala de Soledad de De Jong Gierveld (DJGLS: 11 ítems; DJGLS-6: 6 ítems).
Nombre Original (Inglés)	<i>De Jong Gierveld Loneliness Scale (DJGLS)</i>
Autores Originales	Dras. Jenny de Jong Gierveld y Frans Kamphuis (1985); Jenny de Jong Gierveld & Theo van Tilburg (2006).
Validación Española / LatAm	José Buz y Gerardo Prieto (2013, 2014), Universidad de Salamanca, España.
Eje Clínico y Constructo	Eje II: Procesos Psicológicos. Vínculo Interpersonal, Soledad Subjetiva, Apego y Redes Sociales.
Tipo de Instrumento	Autoinforme dimensional o entrevista estructurada de 11 reactivos (o 6) con respuesta en 3 niveles.
Población y Rango	Adultos y personas mayores (desde 18 años; baremación especializada en > 60 años).
Tiempo de Administración	3 a 5 minutos (forma completa); 2 minutos (forma breve DJGLS-6).
Régimen de Licencia	Acceso abierto para uso clínico, docencia e investigación científica (VU Amsterdam / Buz & Prieto).

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO BIDIMENSIONAL DE WEISS

La DJGLS operacionaliza el modelo cognitivo de la soledad formulado por De Jong Gierveld (1987), que define la soledad como una vivencia subjetiva aversiva originada por la discrepancia percibida entre el tipo, número y calidad de relaciones interpersonales deseadas y las efectivamente experimentadas. El instrumento asume la distinción cualitativa de Robert Weiss (1973) entre dos tipos independientes de soledad:

1. **Soledad Emocional:** Derivada de la ausencia o pérdida irreparable de una figura de apego íntima, cercana y protectora (cónyuge, pareja, progenitor o confidente íntimo). Se manifiesta fenomenológicamente como desolación, vacío visceral y abandono.
2. **Soledad Social:** Resultante de la carencia o desintegración de una red comunitaria, de amigos o grupo de pares con quienes compartir intereses y actividades. Se experimenta como marginación, aburrimiento y falta de pertenencia.

Desde la neurobiología afectiva y social (Cacioppo et al., 2014; Eisenberger, 2012), la soledad crónica activa la “matriz del dolor social” (corteza cingulada anterior dorsal e ínsula anterior), estimulando de forma continua el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal (HHA), la vasoconstricción periférica y mediadores inflamatorios proaterogénicos (IL-6, proteína C reactiva).

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN FACTORIAL DE ÍTEMS

Dimensión de Soledad	Ítems (11)	Ítems (6)	Contenido y Expresión Fenomenológica Evaluada
1. Soledad Emocional	2, 3, 5, 6, 9, 10	3, 9, 10	Sensación de vacío interior, falta de personas en quien confiar íntimamente y vivencia de abandono (reactivos de formulación negativa).
2. Soledad Social	1, 4, 7, 8, 11	1, 4, 11	Disponibilidad de una red amplia de amistades, apoyo vecinal y sentido de pertenencia grupal (reactivos de formulación positiva).

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y CALIBRACIÓN RASCH EN ESPAÑA / LATAM

Calibración Rasch	Evaluación psicométrica sobre N = 614 adultos mayores españoles comunitarios (Buz & Prieto, 2013). Ajuste excelente de los 11 ítems con Infit medio = 0.99 (0.85 a 1.12) y Outfit medio = 0.99 (0.63 a 1.58). Confiabilidad de separación de ítems = 0.99.
Consistencia Interna	Precisión homogénea: KR-20 = 0.77 en muestra general y alfa ordinal = 0.83 en muestra clínica. La forma abreviada DJGLS-6 conserva un alfa de 0.76 (Van Tilburg & De Jong Gierveld, 2006).
Estructura y Unidimensionalidad	El análisis de componentes principales de residuos en Rasch ratifica que el factor primario da cuenta del 52.44% de la varianza empírica, justificando el cómputo de una puntuación global única junto a los subpuntajes específicos.
Validez Concurrente y Divergente	Correlación directa robusta con depresión geriátrica (GDS-15: $r = 0.44$) y afecto negativo (PANAS-N: $r = 0.31$). Correlaciones inversas significativas con satisfacción con la vida (SWLS: $r = -0.32$) y afecto positivo (PANAS-P: $r = -0.30$).
Invarianza Demográfica	Invarianza de medida calibrada entre sexos y estados civiles; viudos y personas que viven solas presentan niveles basales significativamente superiores en la subescala Emocional.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÓMPUTO DE PUNTUACIONES

Cada uno de los reactivos se responde en 3 opciones (**1** = «No», **2** = «Más o menos», **3** = «Sí»). Se aplica el algoritmo de dicotomización oficial de De Jong Gierveld & Kamphuis:

- **Paso 1 (Ítems de Soledad Social - Formulados Positivamente: 1, 4, 7, 8, 11):** Se asigna **1 punto** si responde «No» o «Más o menos»; se asigna **0 puntos** si responde «Sí».
- **Paso 2 (Ítems de Soledad Emocional - Formulados Negativamente: 2, 3, 5, 6, 9, 10):** Se asigna **1 punto** si responde «Sí» o «Más o menos»; se asigna **0 puntos** si responde «No».
- **Paso 3 (Puntuaciones Parciales y Totales):**
 - **Soledad Social:** Suma de ítems sociales (Rango: **0 a 5 puntos**).
 - **Soledad Emocional:** Suma de ítems emocionales (Rango: **0 a 6 puntos**).
 - **Puntuación Total DJGLS-11:** Suma Social + Emocional (Rango: **0 a 11 puntos**).
 - **Forma Abreviada DJGLS-6:** Suma de ítems 1, 4, 11 (social) y 3, 9, 10 (emocional) (Rango: **0 a 6 puntos**).

6. ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA Y PUNTOS DE CORTE (BUZ & PRIETO, 2013)

Estratificación	Puntuación Total	Nivel de Soledad	Conducta Asistencial Recomendada
No Soledad	0 a 2 puntos	Integración relacional plena	Red social y vínculos íntimos satisfactorios. Buen ajuste adaptativo y emocional.
Soledad Moderada	3 a 8 puntos	Déficit relacional significativo	Presencia de insatisfacción afectiva o social. Exploración de la red y fomento de actividades comunitarias.
Soledad Severa	9 a 10 puntos	Aislamiento grave / Desolación	Pérdida profunda de soporte vincular. Alto riesgo de depresión y deterioro cognitivo; intervención activa.
Soledad Extrema	11 puntos	Aislamiento total invalidante	Puntuación máxima; vivencia de abandono absoluto. Protocolo prioritario de enlace social y salud mental.

DISOCIACIÓN DIAGNÓSTICA: SOLEDAD EMOCIONAL VS. SOLEDAD SOCIAL:

Es común observar pacientes que reportan una **Soledad Social nula (0/5)** porque asisten diariamente a centros diurnos o tienen vecinos, pero presentan una **Soledad Emocional máxima (6/6)** por la pérdida reciente de su cónyuge ("rodeado de gente pero completamente solo"). Invitar a un paciente con soledad emocional a "hacer más amigos" agrava el malestar; requiere elaboración de duelo y apego.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN TERAPÉUTICA EN SOLEDAD CRÓNICA

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN DIFERENCIADO BASADO EN LA DJGLS:

- **Paso 1 (Diferenciación de la Subescala Afectada):** Evaluar si el puntaje elevado procede de Soledad Emocional (ítems 2, 3, 5, 6, 9, 10) o de Soledad Social (ítems 1, 4, 7, 8, 11).
- **Paso 2a (Abordaje de Soledad Emocional):** Terapia de duelo, reconstrucción vincular, terapia centrada en la compasión (CFT) y fomento de relaciones cualitativamente significativas de confianza mutua.
- **Paso 2b (Abordaje de Soledad Social):** Prescripción social, revinculación con voluntariados, centros culturales, entrenamiento en habilidades conversacionales y reestructuración de la hipervigilancia social amenazante.
- **Paso 3 (Monitorización):** Un descenso de ≥ 3 puntos en el DJGLS-11 al cabo de 3 meses refleja reconexión social y recuperación del bienestar subjetivo.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN SOLEDAD Y DUELO COMPLICADO EN ANCIANO

Identificación: Varón de 74 años, jubilado, derivado por su médico de atención primaria tras el fallecimiento de su esposa hace 14 meses. Presenta anhedonia, pérdida de apetito, somatizaciones digestivas y abandono del autocuidado.

Evaluación Inicial DJGLS-11 (Línea Base): Puntuación Total = **10/11 puntos** (Rango Severo). Subescala Soledad Emocional = **6/6** (máxima desolación íntima, ítems 2, 3, 5, 6, 9, 10 afirmativos). Subescala Soledad Social = **4/5** (retirada progresiva de sus amigos del club de ajedrez). Escala GDS-15 = 11/15.

Plan Terapéutico: 12 sesiones de psicoterapia individual centrada en duelo complicado (Worden) combinada con el programa municipal de enlace social. Se trabajaron las tareas de aceptación del vacío, redefinición del rol biográfico y gradual reinserción comunitaria con acompañamiento inicial.

Reevaluación a los 4 Meses: Puntuación Total DJGLS-11 = **3/11 puntos** (descenso neto de 7 puntos, transición al límite entre No Soledad y Moderada). La Soledad Emocional descendió a **2/6** y la Soledad Social a **1/5**. El paciente retomó el club de ajedrez y declaró: "Sigo extrañando a mi esposa cada día, pero he vuelto a sentir que la vida me acoge".

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

RIESGO SUICIDA EN PERSONAS MAYORES:

La soledad subjetiva severa (DJGLS ≥ 9) es uno de los predictores independientes más potentes de ideación y conducta suicida en la vejez, a menudo enmascarada bajo quejas somáticas. Evaluar inmediatamente intencionalidad autolítica (C-SSRS).

SOLEDAD VS. AISLAMIENTO OBJETIVO:

No confundir aislamiento objetivo (vivir solo, pocos contactos físicos) con soledad subjetiva (vivencia de vacío y desconexión). Existen personas aisladas sin soledad y personas con redes nutridas que experimentan una profunda soledad emocional.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Buz, J., & Prieto Adánez, G. (2013). Análisis de la Escala de Soledad de De Jong Gierveld mediante el modelo de Rasch. *Universitas Psychologica*, 12(3), 971-981.
2. Buz, J., Sánchez, M. M., & De Jong Gierveld, J. (2014). Factor structure of the De Jong Gierveld Loneliness Scale in Spanish elderly adults. *Anales de Psicología*, 30(2), 588-596.
3. De Jong Gierveld, J., & Kamphuis, F. (1985). The development of a Rasch-type loneliness scale. *Applied Psychological Measurement*, 9(3), 289-299.
4. De Jong Gierveld, J., & Van Tilburg, T. (2006). A 6-item scale for overall, emotional, and social loneliness. *Research on Aging*, 28(5), 582-598.